

Cet examen détaillé de l'uretère — le tube qui conduit l'urine du rein à la vessie — est réalisé pendant que vous êtes endormi sous anesthésie. Votre chirurgien combine plusieurs tests pour localiser précisément un rétrécissement et en mesurer la longueur, afin de planifier la bonne réparation.

À propos de cet examen

Un rétrécissement (une **sténose**) de l'uretère est difficile à évaluer de l'extérieur ; votre chirurgien l'examine donc directement pendant que vous êtes endormi. Selon les besoins, l'examen peut combiner **tout ou partie** de ces techniques :

- **Urétéroscopie diagnostique** — un endoscope souple et fin introduit dans l'uretère pour le visualiser de l'intérieur.
- **Pyélographie rétrograde** — injection de produit de contraste *vers le haut* depuis la vessie, avec radiographies, pour opacifier le canal.
- **Pyélographie antégrade** — si vous avez un tube de drainage rénal, le produit de contraste est injecté *vers le bas* depuis le rein, à travers le rétrécissement.
- **Cystoscopie / cystographie** — examen de la vessie et radiographies de celle-ci.

L'objectif est une cartographie précise : localisation, longueur et degré du rétrécissement. Une **sonde JJ** (endoprothèse) ou un tube rénal peut être mis en place ou changé au cours de la même séance.

Est-ce sans danger ?

Oui. C'est un examen courant et peu risqué. La plupart des patients ne ressentent qu'un léger saignement urinaire, des brûlures passagères ou une douleur lombaire après l'intervention. Les complications rares comprennent une infection urinaire ou une irritation brève de l'uretère ; une lésion urétérale mineure est exceptionnelle. L'anesthésie est généralement très sûre.

COMPRENDRE LES TERMES

Uretère

Tube qui conduit l'urine du rein à la vessie.

Rétrécissement (sténose)

Zone cicatricielle et rétrécie qui ralentit ou bloque l'écoulement de l'urine.

Urétéroscopie

Visualisation de l'intérieur de l'uretère avec un endoscope souple et fin.

Pyélographie rétrograde

Radiographies de l'uretère et du rein après injection de produit de contraste vers le haut depuis la vessie.

Pyélographie antégrade

Radiographies après injection de produit de contraste vers le bas depuis un tube de drainage rénal.

Sonde de néphrostomie

Tube qui draine le rein par le dos ; le produit de contraste peut y être injecté.

Produit de contraste

Liquide visible en blanc sur la radiographie pour opacifier le canal.

Sonde JJ (endoprothèse)

Petit tube souple maintenant l'uretère ouvert ; peut être mis en place ou changé.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Vous êtes endormi sous anesthésie, vous ne ressentez donc rien pendant l'examen. Après, attendez-vous à de légères brûlures en urinant, une douleur lombaire sourde ou des urines légèrement rosées pendant un ou deux jours. C'est une courte intervention et vous rentrez généralement chez vous le jour même.

Comment vous préparer (Avant l'examen)

- Cet examen se fait sous **anesthésie** — respectez toutes les consignes chirurgicales (jeûne et médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Une **analyse d'urine** vérifie l'absence d'infection — toute infection active doit être traitée au préalable.
- Laissez en place tout **tube rénal ou sonde JJ** existant, et **prévoyez un accompagnateur** pour le retour.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez déjà eu une réaction au **produit de contraste ou à l'iode**
- Prenez un **anticoagulant**, ou présentez des signes d'infection urinaire

Déroulement de l'examen

- 1 Vous êtes endormi sous anesthésie et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Un cystoscope est introduit dans la vessie. Le produit de contraste est injecté vers le haut dans l'uretère pendant la prise de radiographies, et/ou un endoscope est introduit dans l'uretère pour le visualiser de l'intérieur.
- 3 Si vous avez un tube rénal, le produit de contraste peut être injecté vers le bas pour montrer le rétrécissement des deux directions.
- 4 Les résultats sont cartographiés ; une sonde JJ ou un tube rénal est mis en place ou changé si nécessaire.

Après l'examen

- Vous vous réveillez de l'anesthésie et rentrez généralement **chez vous le jour même** avec un accompagnateur.
- De légères brûlures, une douleur lombaire ou des urines rosées **pendant un ou deux jours** sont normales. Boire davantage d'eau aide.
- Si une sonde JJ a été posée, des envies fréquentes ou une légère gêne à la miction sont normales.
- Votre chirurgien analyse les résultats et discute avec vous des prochaines étapes de la réparation.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Une douleur lombaire ou abdominale sévère ou croissante
- Des saignements importants ou des caillots dans les urines
- Des difficultés à uriner, ou des nausées ou vomissements persistants

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Cet examen cartographie un rétrécissement de l'uretère pendant que vous êtes endormi (endoscope + produit de contraste, par le bas et/ou par le haut), pour planifier la réparation.
2. Sous anesthésie : jeûne et consignes médicamenteuses, traitement de toute infection, laissez tout tube ou sonde en place, et prévoyez un accompagnateur.
3. La plupart des patients rentrent le jour même. Légères brûlures, douleur lombaire ou urines rosées pendant un ou deux jours sont normales — buvez davantage d'eau.